

Monotropisme en zijn web van comorbiditeit: directe en indirecte links aan gedrags-, psychiatrische en neuroontwikkelingscondities

Een geciteerd onderzoeksdossier.

Samenvatting

Monotropisme (Murray, Lawson & Lesser, 2005) is een theorie van autistische aandacht die autisme kadert als een verschil in *brontoewijzing*: een monotrope geest concentreert verwerkingsbronnen in een klein aantal hoog-geactiveerde „aandachtstunnels”, waardoor minder bronnen overblijven voor perifere kanalen. Een zelfrapportagemeting uit 2023 — de **Monotropism Questionnaire (MQ)** — biedt de eerste empirische validatie, tonend dat autistische en ADHD-mensen significant hoger scoren dan niet-autistische/niet-ADHD-controles [1][2][3]. Een nauw verwant door-vakgenoten-beoordeeld model, Goldknopfs **atypische brontoewijzing**-account, betoogt dat dezelfde versmalde-intense aandacht autismes zintuiglijke, sociale, executieve en motorische kenmerken kan samenbinden — terwijl waarschuwend dat het „hoogstwaarschijnlijk een factor is bij autistische mensen met sterke zintuiglijke symptomen”, niet de enige oorzaak [4].

Omdat monotropisme een theorie is van *hoe bronnen worden besteed*, rimpelt het plausibel in vele domeinen. Het eerlijke beeld splitst echter in drie lagen:

- **Laag 1 — Directe, empirisch ondersteunde links.** De autisme–ADHD-overlappending („AuDHD”) is de sterkste: de MQ toont dat monotrope aandacht verhoogd is in *beide* condities, herkaderend

„monotrope splitsing" (concurrerende of onstabiele tunnels) als een echt, meetbaar aandachts-fenotype [2][3][5]. Mechanismeniveau overlappingsen — atypische **interoceptie** en **executieve disfunctie** — zijn goed bewezen en helpen downstream-problemen met eten, rommel en vermijding te verklaren [6][7][8].

- **Laag 2 — Indirecte, gedeeld-mechanisme comorbiditeit.** Autism overlapt merkbaar met **anorexia/restrictief eten** en **OCD**. In elk geval is de comorbiditeit echt en gerepliceerd, maar de *best-bewezen* brug is een gedeeld mechanisme (interoceptie; ego-syntone vs ego-dystone verwerking) eerder dan monotropisme specifiek [6][9][10].
- **Laag 3 — Plausibele extrapolatie of betwiste constructen.** Enkele links in het populaire kader — „noodlotsstapels" als een monotrope objectpermanentie-faling, agorafobie als een primaire monotrope uitkomst, **PDA** als een onderscheiden profiel — rusten op zwakker of betwist bewijs en moeten als hypothesen worden behandeld, niet als vaststaande feiten [11][12][13].

Doorlopend een terugkerend thema: veel gedragingen die op afzonderlijke „stoornissen" lijken worden beter gelezen als **de cognitieve kosten van een smal aandachtssysteem dat botst met een polytrope wereld** — maar slechts enkele van die lezingen zijn direct getest.

1. Funderingen: wat monotropisme is, en hoe solide het is

Monotropisme poneert dat geesten verschillen in hoe ze aandachtsbronnen verdelen. Een **polytrope** geest houdt vele belangstellingskanalen tegelijk actief (breed, ondiep, gemakkelijk schakelen); een **monotrope** geest trekt bronnen in enkele intensief geactiveerde „aandachtstunnels" (smal, diep, moeilijk te schakelen) [1][3]. De oprichters — Dinah Murray, Wenn Lawson en Mike Lesser — presenteerden het idee eerst op de Durham-autismeconferenties vanaf 1992 en formaliseerden het in 2005, betogend dat het autistische trekken verklaart (speciale interesses, behoefte aan gelijkblijvendheid, distress bij transities, detail-focus) beter dan alleen-deficit-modellen [1][14].

Zijn wetenschappelijke status is de laatste jaren verschoven:

- Het is **empirisch meetbaar**. De MQ (Garau et al., 2023) is een 47-item zelfrapportage-instrument getest op 1.110 deelnemers (756 autistisch, 354 niet-autistisch). Autistische en ADHD-deelnemers scoorden significant hoger dan controles [2][3].
- Het heeft een **door-vakgenoten-beoordeelde mechanistische neef**. Goldknopfs „atypische brontoewijzing"-model (*Frontiers in Integrative Neuroscience*, 2013) operationaliseert de intuïtie: bij autisme zijn aandachtsbronnen **versmald** (naar minder/kleinere gebieden, modaliteiten en verwerkingsstadia, soms intenser) en/of **verminderd** in totale capaciteit — een kader dat expliciet taal, sociale cognitie, zintuiglijke/aandachtelijke atypicaliteit en executieve/motorische verschillen samenbindt [4].
- Het zit **naast, niet in plaats van**, andere cognitieve theorieën (Theory of Mind; zwakke centrale coherentie / detail-gerichte cognitieve stijl (Happé & Frith, 2006); executieve disfunctie) [4][15].
- Het is nog een **model, geen biomarker**. Goldknopf is expliciet dat het één factor is onder meerdere, „hoogstwaarschijnlijk" saillant bij autistische mensen met sterke zintuiglijke symptomen [4]. Murray en collega's kadertten monotropisme vergelijkbaar als een verenigende *lens*, niet een volledige etiologie [1][14].

Implicatie voor de rest van dit dossier: monotropisme is een geloofwaardig, toenemend gevalideerd ordenend idee, maar zijn *verklarende reikwijdte* in elke comorbiditeit moet geval voor geval worden beargumenteerd — niet verondersteld.

2. Laag 1 — Directe links: het neuroontwikkelingscluster

2.1 AuDHD en de „monotrope splitsing" (*sterkste directe link*)

Autisme en ADHD co-voorkomen veel vaker dan toeval zou voorspellen: ADHD is aanwezig bij ongeveer **30–80%** van autistische mensen, en autisme bij ongeveer **20–50%** van degenen met ADHD [5]; een meta-analyse plaatst ASD-symptoompercentages in ADHD-samples rond **21%** [16]; één grote Medicaid-studie vond dat **27%** van autistische

volwassenen zonder verstandelijke beperking een co-voorkomende ADHD-diagnose hadden — ongeveer 10× het algemene percentage [17]. De overlapping is aanzienlijk genetisch (~50–72%) [18].

Monotropisme helpt een oude puzzel oplossen: als autisme „hyperfocus” is en ADHD „aandachtstekort”, waarom co-voorkomen ze dan? De MQ beantwoordt dit empirisch — **ADHD-mensen, vooral AuDHD-mensen, zijn ook hoog monotroop** [2][3]. Hyperfocus bij ADHD (Grotewiel et al., 2022) is conceptueel vrijwel identiek aan de monotrope tunnel [19]. Het „monotrope splitsing”-kader herkaderdt AuDHD dus niet als tegengestelden maar als **een onstabiel systeem van concurrerende of snel-schakelende aandachtstunnels**: het brein eist diepe monotrope focus maar kan de tunnel niet stabiliseren, wat de vertrouwde AuDHD-oscillatie tussen intense betrokkenheid, snelle burnout en chronische onderstimulatie produceert [19][20].

Kanttekening: het „meerdere concurrerende tunnels”-mechanisme is *plausibel en consistent met de MQ-data* maar nog niet direct getest als dynamiek; het moet als sterke hypothese worden gelezen.

2.2 Autistische burnout en tunnelbreuk

Autistische burnout — chronische uitputting, verlies van vaardigheden en verminderde tolerantie — wordt toenemend gelinkt aan de cumulatieve kosten van constant tunnel-schakelen, maskeren en eisen die capaciteit overschrijden, met onvoldoende herstel-/flow-tijd [20][21]. Dit is een gebied waar monotropisme heuristisch krachtig is (elke geforceerde transitie is een tunnelbreuk), hoewel de burnout-literatuur zelf nog aan het rijpen is en het monotropisme→burnout-pad grotendeels klinisch/first-person is eerder dan experimenteel vastgesteld [20].

2.3 Vraagvermijding en PDA (*betwist construct*)

Een vraag — „maak je klaar”, „vul dit formulier in” — kan worden ervaren als een gewelddadige inbreuk in een flow-staat. Dit is het intuïtieve monotrope account van **vraagvermijding**. Het meer specifieke construct **Pathological Demand Avoidance (PDA)**, gemunt door Elizabeth Newson in de jaren 1980 en nu vaak herkaderd als „Pervasive Drive for Autonomy”, beschrijft een angst-gedreven behoefte aan controle en vermijding van gewone vragen [11][22].

Twee dingen moeten worden gescheiden:

- **Vraag-vermijndend gedrag is echt en veelvoorkomend** bij autisme, en het monotrope „tunnelbreuk“-account is een redelijk *mechanistisch verhaal* voor de paniek en weerstand die het produceert.
- **PDA als onderscheiden profiel of subtype is niet vastgesteld.** De Britse National Autistic Society stelt „geen onderzoek heeft sterk bewijs gevonden voor [PDA] als onderscheiden profiel“ [11]; Newsons funderende studie is bekritisiseerd wegens **cirkelredenering en overinterpretatie** (groepen gedefinieerd door de onderzoekers werden vervolgens „bestudeerd“) [12][13]; en overzichten noteren aanhoudende problemen met definitie, constructvaliditeit en meting [23]. Een 2023-overzicht is pointillig getiteld „*Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion*“ [13].

Dus het kader van de brontekst is half juist: de *ervaring* (een vraag versplintert de tunnel) wordt goed beschreven door monotropisme; de *diagnostische entiteit* (PDA) is betwist en moet niet als vastgesteld worden gepresenteerd.

3. Laag 2 — Indirecte, gedeeld-mechanisme comorbiditeit

3.1 Anorexia en restrictief eten

De autisme–anorexia-overlapping is robuust en bidirectioneel: ongeveer **20–30%** van eetstoornis-patiënten toont klinisch significante autistische trekken, met de hoogste percentages bij anorexia nervosa en ARFID [6] [24]; omgekeerd hebben autistische volwassenen verhoogde eetstoornis-percentages. Cruciaal: autistische trekken worden **voor** ES-begin geobserveerd, dus de overlapping is niet slechts een verhongeringseffect [6].

De best-bewezen *mechanistische* brug is **interoceptie** — de perceptie van interne lichaamssignalen (hartslag, verzadiging). Atypische interoceptie is betrokken bij de etiologie van *zowel* autisme als eetstoornissen en „kan, althans deels, verantwoordelijk zijn“ voor hun comorbiditeit [6]. Dezelfde interoceptieve atypicaliteit onderligt

alexithymie (moeite met het identificeren/verbaliseren van emoties), aanwezig bij ~50% van autistische mensen en zelf gelinkt aan eetpathologie [7][8].

Waar monotropisme past (en niet past): het is redelijk om te zeggen dat een monotrope persoon diep in een tunnel misschien honger-cues *mist* — maar de specifieke claim van de brontekst dat „monotropisme interoceptie vermindert" overdrijft de causale keten. De bewezen relatie is **autisme** → **atypische interoceptie/alexithymie** → **eet-kwetsbaarheid**; monotropisme is een parallel kenmerk van autisme, niet de *getoonde oorzaak* van het interoceptieve verschil [6][7]. Voedsel/calorie-tracking kan ook een tunnel op zich worden, maar dit is mechanisme-plausibel eerder dan getest.

3.2 OCD vs hyperfocus: een genuine onderscheid

Autisme en OCD co-voorkomen aanzienlijk: ~**17%** van autistische mensen voldoet aan OCD-criteria, vs ~1–2% in de algemene bevolking [9]. Ondanks oppervlakkige gelijkenis (repetitief gedrag, rigiditeit), verschilt de **affectieve drijver** en dit is klinisch goed vastgesteld:

- **Autistische** beperkte/repetitieve interesses en routines zijn typisch **ego-syntoon** — plezierig, zelf-kalmerend, belangstellings-gedreven, vaak regulerend.
- **OCD-compulsies** zijn **ego-dystoon** — ongewenst, angst-gedreven, uitgevoerd om gevreesde uitkomsten te neutraliseren [9][10].

Het onderscheid van de brontekst is dus correct en bewijs-ondersteund, en wordt direct bevestigd door autistische deelnemers zelf: in een kwalitatieve studie rapporteerden zij dat repetitief gedrag „deel is van wie ze zijn", terwijl OCD-symptomen „conflicteerden met hoe ze zichzelf zien" [10]. Dezelfde studie kadert het co-voorkomen treffend als „*Autism is the arena and OCD is the lion*" — OCD-symptomen kunnen autistische speciale interesses „kapen", hun intensiteit en distress opblazend [10]. Monotropisme voegt context toe (een tunnel kan worden *gevangen* door OCD-inhoud) maar de differentiatie rust op de ego-syntoon/dystoon-as, niet op monotropisme per se.

3.3 Angst en affectieve stoornissen (het substraat onder „agorafobie“)

Angst is een van de meest voorkomende autisme-comorbiditeiten (één secundair overzicht citeert ≥ 1 psychiatrische comorbiditeit bij ~86% van autistische mensen) [25]. Twee mechanisme-punten zijn belangrijk voor het gedragscluster hieronder: (i) **zintuiglijke over-responsiviteit** en angst zijn gelinkt, en door *contextconditionering* produceren ze **gedragsvermijding van gegeneraliseerde locaties** (restaurants, winkels, feesten) [26]; (ii) het frequente co-voorkomen van alexithymie/interoceptieve moeite betekent dat emotionele toestanden vaak slecht worden gelabeld, wat diffuse angst voedt [7].

4. Laag 3 — Gedrags-/functioneel cluster: rommel, hording, vermijding, sociale terugtrekking

4.1 Rommel, „noodlotsstapels“, en executieve disfunctie

Het *fenomeen* is goed ondersteund: autistische en ADHD-mensen tonen hoge percentages desorganisatie en rommel, en de best-bewezen route is **executieve disfunctie** — tekorten in categorisatie, besluitvorming, planning en werkgeheugen [8][27]. Hording-symptomen zijn verhoogd zowel bij ADHD (met een „speciale link met onoplettendheid“ [8a]) als bij autisme [8]; bij autisme specifiek toont kwalitatief werk dat moeite met weggooien is gelinkt aan **belangstellings-hechtingen en betekenis**, niet slechts objectwaarde [28].

Kanttekening bij de brontekst: de specifieke claim dat rommel aanhoudt wegens een autistisch „**objectpermanentie-tekort**“ („uit het oog, uit het hoofd“) wordt **niet ondersteund door door-vakgenoten-beoordeeld bewijs** dat ik kon lokaliseren. Objectpermanentie is typisch *intact of superieur* bij autisme; de „uit het oog, uit het hoofd“-ervaring wordt beter gelezen als een **werkgeheugen-/aandachtstoewijzing**-effect (een getunnelde geest heroriënteert niet naar opgeslagen items) dan een perceptuele-objectpermanentie-faling. Het bewezen mechanisme voor rommel blijft **executieve disfunctie plus belangstellings-hechting**, dat de monotrope/AuDHD-populatie overlapt maar niet uniek „monotroop“ is [4][8][28].

4.2 Hording-spectrumgedrag

Hordingstoornis treft ~1,5–6% van de algemene bevolking maar is verhoogd bij autisme [29]. Bij autistische volwassenen wordt hording-achtige moeite met weggooien frequent gerapporteerd naast **cognitieve (executieve) moeilijkheden en sterke belangstellings-/betekenis-hechtingen** — items zijn knooppunten in een web van ideeën en toekomstig nut, dus weggooien voelt verlies [28]. Dit is consistent met een monotrope *stijl* (diepe verwerking van objecten) maar, weer, de bewezen drijver is EF/hechting, gedeeld over neuroontwikkelingscondities [8].

4.3 Agorafobie en „veilige-ruimte“-begrenzing (*behoeft correctie*)

De brontekst kadert agorafobisch thuis-opgesloten-zijn als een bijna-directe monotrope uitkomst. De data zijn genuanceerder:

- Agorafobie is verhoogd bij autisme — ~**23–25%** van autistische volwassenen (zonder verstandelijke beperking) vs ~1,3% in de algemene bevolking — **maar het is minder vaak dan sociale fobie of GAD**, en het effect concentreert zich bij degenen zonder VB [25].
- De beter-bewezen drijver is **zintuiglijke over-responsiviteit + sociale angst**, met context-geconditioneerde vermijding van overweldigende locaties — d.w.z. het „veilige-ruimte“-gedrag is echt maar is **secundair aan zintuiglijke/sociale angst**, geen primair monotroop fenomeen [25][26].

Dus: monotropisme helpt verklaren *waarom* de buitenwereld verstorend voelt (onvoorspelbaar, polytroop, tunnel-brekend), maar het resulterende opgesloten-zijn classificeren als „agorafobie“ specifiek voor monotropisme overdrijft de link. Het is een zintuiglijk-angst-gedreven vermijding die de monotrope ervaring *overlapt*.

4.4 Sociale terugtrekking, info-dumping, en het dubbele-empathie-probleem

Sociale interactie is genuine polytroop — het vereist gelijktijdig volgen van gezichten, toon, hiërarchie, timing en ongeschreven regels — dus het is disproportioneel kostbaar voor een monotroop systeem, een punt consistent met Goldknopfs bronmodel [4]. De intuïtie van de brontekst is juist.

Maar het scherpere, *empirisch ondersteunde* kader voor de resulterende communicatie-breuk is het **dubbele-empathie-probleem** (Milton, 2012; 2017): de moeite is *bidirectioneel* en relationeel — een „ontwrichting in de wederkerigheid tussen twee verschillend gezinde sociale actoren” — geen eenzijdig empathie-tekort bij de autistische persoon [30]. Empirisch werk toont nu dat niet-autistische waarnemers het dubbele-empathie-probleem *zowel detecteren als demonstreren* in gemengde interacties [31]. „Info-dumping” past natuurlijk: het is diepte-zoekende communicatie van een monotroop systeem, dat faalt wanneer de partner de diepte niet kan evenaren — een mismatch van verwerkingsstijlen, geen gebrek aan empathie [30][31].

Hiaat om te vlaggen: de DEP-literatuur sluit nog grotendeels autistische kinderen, niet-sprekende mensen en mensen met verstandelijke beperking uit, dus generalisatie is beperkt [32].

5. De grens: waar het monotrope account te ver reikt

Claim in bron/leken-kader	Bewijsstatus	Beter kader
Monotropisme <i>veroorzaakt</i> autismes kenmerken	Deels ondersteund (MQ; Goldknopf)	Eén gevalideerde ordenende factor onder meerdere; sterkst bij zintuiglijk autisme [1] [4]
AuDHD = „monotrope splitsing” (concurrerende tunnels)	Sterk + direct meetbaar (MQ)	Een echt aandachts-fenotype; dynamisch mechanisme is hypothese-niveau [2][3]
PDA is een onderscheiden autisme-profiel	Betwist	Vraagvermijding is echt; PDA-als-entiteit mist constructvaliditeit [11][12][13]
Monotropisme <i>vermindert interoceptie</i> → anorexia	Indirect	Brug is autisme→interoceptie/alexithymie→eet-kwetsbaarheid; monotropisme is parallel, niet de getoonde oorzaak [6][7]
Rommel door een „objectpermanentie-tekort”	Niet-ondersteund	Executieve disfunctie + belangstellings-hechting; geen perceptueel objectpermanentie-tekort bewezen [4][8] [28]

Claim in bron/leken-kader	Bewijsstatus	Beter kader
Agorafobie als primaire monotrope uitkomst	Overdreven	Secundair aan zintuiglijke over-responsiviteit + sociale angst; minder vaak dan GAD/sociale fobie [25][26]
OCD vs monotrope „obsessies" verschillen in affect	Goed ondersteund	Ego-dystoon (OCD) vs ego-syntoon (autistische interesse); OCD kan tunnels „kapen" [9][10]
Dubbele-empathie-probleem verklaart sociale breuk	Ondersteund (maar hiaten)	Bidirectionele mismatch; steekproeven vertekenen naar sprekende volwassenen zonder VB [30][31][32]

6. Open vragen

- 1. Dynamische tunnel-test.** De MQ is een *trait*-maat. Is de „monotrope splitsing" (concurrerende/onstabiele tunnels bij AuDHD) observeerbaar in real-time aandacht/EEG? Largelijk ongetest.
 - 2. Causale pijl naar interoceptie.** Produceert een monotrope bronverdeling interoceptieve atypicaliteit, of delen ze een gemeenschappelijke upstream-oorzaak? Huidig bewijs kan deze niet scheiden [6][7].
 - 3. PDA-resolutie.** Zal vraagvermijdingsonderzoek convergeren naar een gevalideerd, meetbaar construct, of een betwist leken/klinisch categorie blijven? [11][13]
 - 4. Rommel-mechanisme.** Is „uit het oog, uit het hoofd" een werkgeheugen/toewijzing-effect (plausibel) of iets anders? Geen toegewijde studie gevonden.
 - 5. DEP-generaliseerbaarheid.** Hoe opereert het dubbele-empathie-probleem voor niet-sprekende autistische mensen, kinderen en mensen met co-voorkomende verstandelijke beperking? [32]
 - 6. Burnout.** Wat is de specifieke, testbare bijdrage van monotrope tunnelbreuk aan autistische burnout versus maskeren, trauma en chronische vraag? [20]
-

Bronnen

- [1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361305051398> [2]
- Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A., & Fletcher-Watson, S. (2023). The Monotropism Questionnaire (MQ). Open Science Framework (preprint). Commentaar/samenvatting:
<https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-and-the-monotropism-questionnaire> ; spiegel: <https://stimpunks.org/monotropism-questionnaire> [3] Autistic Realms / Neurodiverse Connection (Edgar) — samenvatting van MQ-bevindingen (47 items; N=1.110; autistisch + ADHD scoren significant hoger): <https://autisticrealms.com/monotropism-vs-polytropism-adhd-audhd-autistic-attention> [4] Goldknopf, E. J. (2013). Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism. *Frontiers in Integrative Neuroscience*. PMC3872719.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719> [5] Psych Scene Hub — ADHD en autisme comorbiditeit review (ADHD bij ~30–80% van ASD; ASD bij ~20–50% van ADHD; citeert Lau-Zhu 2019; Hollingdale 2019):
<https://psychscenehub.com/psychinsights/adhd-and-autism-comorbidity-a-comprehensive-review> [6] Adams, K. L., Murphy, J., Catmur, C., & Bird, G. (2022). The role of interoception in the overlap between eating disorders and autism: methodological considerations. *European Eating Disorders Review*. PMC9543236.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9543236> [7] Klein, M., Witthöft, M., & Jungmann, S. M. (2025). Interoception in individuals with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry* (10.3389/fpsyt.2025.1573263) — ~50% van autistische mensen heeft alexithymie, gemedieerd door interoceptieve tekorten.
<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1573263/full> [8] Morein-Zamir, S., Kasese, M., Chamberlain, S. R., & Trachtenberg, M. (2020). Elevated levels of hoarding in ADHD: a special link with inattention. *Journal of Psychiatric Research*. PMC7612156.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7612156> — [8a] de „speciale link met onoplettendheid" is de eigen ondertitel van het paper. Zie ook Drake Institute over ADHD/executieve disfunctie:
<https://drakeinstitute.com/articles/adhd/adhd-and-executive-dysfunction-connection> [9] Animosanopsychiatry — systematic-review samenvatting:

~17% van autistische mensen voldoet aan OCD-criteria vs ~1–2% algemeen; ego-syntoon vs ego-dystoon onderscheid:

<https://animosanopsychiatry.com/blog/ocd-vs-autism-similarities-differences-and-overlaps> [10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). "Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (kwalitatief). PMC11497754. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754> [11] National Autistic Society — Demand avoidance („geen onderzoek heeft sterk bewijs gevonden voor [PDA] als onderscheiden profiel“): <https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/behaviour/demand-avoidance> [12] Frontiers in Education (2024). Methods of studying PDA — kritiek op Newsons cirkelredenering (Green et al. 2018; O'Nions & Eaton 2020): <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1230011/full> [13] Kildahl, A., et al. (2023). Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion. PubMed 36892327. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36892327> [14] Murray, F. (Lawson) (2018). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist* (BPS). <https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism> [15] Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: detail-focused cognitive style in ASD. *J Autism Dev Disord* 36:5–25 (geciteerd via Frontiers 2024 vergelijkende studie): <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1348074/full> [16] Hollingdale, J., et al. (2019). Meta-analytic review of ASD symptoms in ADHD (geciteerd via Psych Scene Hub en Autistica): <https://www.autistica.org.uk/what-is-autism/adhd-and-autism> [17] Children's Hospital of Philadelphia — 27% van autistische volwassenen zonder VB had co-voorkomend ADHD (~10× algemeen): <https://www.chop.edu/news/rates-adhd-remain-high-adulthood-among-patients-autism> [18] Behavioral Innovations — samenvatting van genetische overlap (~50–72%): <https://behavioral-innovations.com/blog/the-sudden-rise-of-audhd> [19] Autistic Scholar — "Revisiting monotropism" (AuDHD als concurrerende tunnels; referenties Grotewiel et al. 2022 over ADHD-hyperfocus): <https://www.autisticscholar.com/monotropism> [20] Neurodiverse Connection (Edgar) — Monotropism, young people and autistic burnout: <https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-young-people> ; Autistic Realms — Reclaiming rest: <https://autisticrealms.com/reclaiming-rest>

[autistic-burnout-monotropism-and-resistance](#) [21] National Autistic Society — What is monotropism? (flow-staten; referenties Heasman et al. 2024 „autistic flow theory"): <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism> [22] PDA North America — What is PDA? (Newson, 1980s; herkadering „Pervasive Drive for Autonomy"): <https://pdanorthamerica.org/what-is-pda> [23] O'Nions, V., et al. (2016). Identifying features of PDA using the DISCO. PMC4820467. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4820467> [24] Nickel, K., Maier, S., Endres, D., & Joos, A. (2019). Systematic Review: Overlap Between Eating, Autism Spectrum, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Frontiers in Psychiatry*. PMC6796791 (citeert ook Westwood, Mandy & Tchanturia 2017; Huke et al. 2013). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6796791> [25] Discussing Psychology (Loker) — agorafobie bij autisme ~23–25% (zonder VB) vs ~1,3% algemeen; minder vaak dan sociale fobie/GAD (secondaire bron, leunend op Helles et al. 2020 en Lugnegård et al. 2012): <https://www.discussingpsychology.com/agoraphobia-and-autism-are-they-intrinsically-linked> [26] Green, S. A., & Ben-Sasson, A. (2010). Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship? *Journal of Autism and Developmental Disorders* — contextconditionering en vermijding. PMC2980623. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623> [27] Embrace Autism — Autism and hoarding (executieve functie, besluitvorming): <https://embrace-autism.com/autism-and-hoarding> [28] Goldfarb, Y., Zafrani, O., Hedley, D., & Yaari, M. (2021). Autistic adults' subjective experiences of hoarding and self-injurious behaviors (kwalitatief). *Autism*. PMC8264636. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8264636> [29] Abouzed, M., Gabr, A., Elag, K. A., Soliman, M., Elsaadouni, N., Elzahab, N. A., & Barakat, M. (2024). The prevalence, correlates, and clinical implications of hoarding behaviors in high-functioning autism. *Scientific Reports* (s41598-024-75371-8). <https://www.nature.com/articles/s41598-024-75371-8> [30] Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the 'double empathy problem'. *Disability & Society* 27(6):883–887 ; Milton (2017) uitbreiding. Samenvatting: <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/double-empathy> [31] Jones, D. R., Botha, M., Ackerman, R. A., & King, K. (2024). Non-autistic observers both detect and demonstrate the double empathy problem when evaluating interactions

between autistic and non-autistic adults. *Autism*. PMC11308351.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11308351> [32] Wikipedia —
Double empathy problem (erkende onderzoekshiaten: kinderen, niet-
sprekend, verstandelijke beperking):
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_empathy_problem

Notitie over bewijslagen: Laag 1 = directe, gerepliceerde meting (MQ;
AuDHD-percentages); Laag 2 = gerepliceerde comorbiditeit met een
bewezen gedeeld mechanisme; Laag 3 = plausibele extrapolatie,
enkelvoudige bron of betwist construct. Zie §5.